

ID Paciente: P001

NHC: NHC-2019-004821

Generado: 09/04/2026

HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

1. Datos del paciente

Nombre completo	Carmen Vidal Soler
Sexo	Mujer
Fecha de nacimiento	14/03/1958 (67 años)
DNI	52.847.301-K
Teléfono	612 344 789
Municipio	Castelló de la Plana
Médico responsable	Dra. Laura Montés Ferrer
Especialidad	Endocrinología y Nutrición

2. Antecedentes personales

- Diabetes mellitus tipo 2 (diagnóstico 2011)
- Hipertensión arterial esencial (diagnóstico 2014)
- Dislipemia mixta en tratamiento farmacológico
- Obesidad grado I (IMC 32,4 kg/m²)
- Hipotiroidismo primario autoinmune (2017)
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Madre: DM2 y cardiopatía isquémica. Padre: HTA fallecido de ACV.

3. Historia clínica

Paciente de 67 años con diabetes mellitus tipo 2 de 13 años de evolución, mal controlada en los últimos 18 meses a pesar de ajustes sucesivos del tratamiento. Refiere poliuria y polidipsia ocasionales, sin episodios hipoglucémicos documentados. Cumplimiento terapéutico irregular por olvidos frecuentes. Dieta hipocalórica con escasa adherencia; actividad física nula desde jubilación hace 2 años. Tensión arterial habitualmente elevada en domicilio (lecturas 145-155/88-94 mmHg). Niega dolor torácico, disnea o claudicación intermitente. Última revisión oftalmológica hace 14 meses: retinopatía diabética no proliferativa leve bilateral.

4. Exploración física

Peso / Talla / IMC	84 kg · 161 cm · 32,4 kg/m ²
Tensión arterial	152/90 mmHg (brazo derecho, sedestación)
Frecuencia cardíaca	78 lpm, rítmica
Temperatura	36,4 °C

Saturación O2	97 % (aire ambiente)
Auscultación cardiaca	Tonos rítmicos, sin soplos audibles
Auscultación pulmonar	Murmullo vesicular conservado
Abdomen	Blando, depresible, sin masas. Hepatomegalia leve a 2 cm de reborde costal
MMII	Sin edemas. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Monofilamento: hipoestesia discreta pie derecho

■ 5. Tratamiento farmacológico actual

Medicamento	Posología
Metformina 1.000 mg	1 comp. con desayuno y cena
Empagliflozina 10 mg	1 comp. en desayuno
Linagliptina 5 mg	1 comp. en desayuno
Amlodipino 10 mg	1 comp. en desayuno
Losartán 100 mg	1 comp. en cena
Atorvastatina 40 mg	1 comp. en cena
Levotiroxina 75 mcg	1 comp. en ayunas
AAS 100 mg	1 comp. con comida

■ 6. Nota de seguimiento — 18/02/2025

Motivo de consulta	Revisión trimestral endocrinología — control glucémico y cardiovascular
--------------------	---

Subjetivo (anamnesis):
La paciente acude acompañada de su hija. Refiere haber comenzado a usar el medidor de glucemia con más regularidad tras la última visita. Episodio de mareo postural hace 3 semanas que cede espontáneamente; no pérdida de conciencia. Niega palpitaciones. Continúa sin actividad física estructurada aunque refiere paseos de 20 minutos 3 días a la semana. Dieta mejorada aunque con transgresiones los fines de semana. Buen cumplimiento del resto de la medicación.

Objetivo (datos clínicos):
HbA1c 8,2% (previa 8,7% hace 3 meses). TA 148/88 mmHg. Peso 83 kg (-1 kg). Glucemia basal 174 mg/dL. Sin hipoglucemias documentadas.

- Plan terapéutico:**
- Intensificar educación diabetológica: se deriva a enfermería de endocrinología.
 - Aumentar empagliflozina a 25 mg/día ante tolerancia correcta y beneficio renal/CV.
 - Añadir amlodipino nocturno si TA sigue >145/90 en 4 semanas (automedida domiciliaria).
 - Solicitar nueva HbA1c, perfil lipídico, función renal y microalbuminuria en 3 meses.
 - Derivar a oftalmología para revisión anual de fondo de ojo.
 - Próxima revisión en 3 meses (mayo 2025) o antes si empeoramiento.

■ 7. Resultados de laboratorio — 15/02/2025

Parámetro	Resultado	Referencia	Flag	Unidades
HbA1c	8,2	< 7,0	H	%

Glucosa basal	174	70 – 100	H	mg/dL
Creatinina	0,92	0,50 – 1,10	N	mg/dL
FGe (CKD-EPI)	68	≥ 60	N	mL/min/1,73m ²
Microalbuminuria	42	< 30	H	mg/g creat.
Colesterol total	198	< 200	N	mg/dL
LDL-c	112	< 70 (alto risg)	H	mg/dL
HDL-c	44	> 50	L	mg/dL
Triglicéridos	187	< 150	H	mg/dL
TSH	2,1	0,4 – 4,0	N	mUI/L
ALT (GPT)	38	< 40	N	U/L
Na	139	136 – 145	N	mEq/L
K	4,1	3,5 – 5,0	N	mEq/L

Observaciones: Leve microalbuminuria persistente compatible con nefropatía diabética incipiente. LDL-c fuera de objetivo (meta < 70 mg/dL por riesgo cardiovascular alto). Se recomienda aumentar dosis de estatina o valorar ezetimiba en próxima visita.

Documento de uso exclusivo para investigación. Todos los datos son ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de información biomédica y clínica.